

抗抑郁药

舍曲林

Sertraline

SSRI

半衰期 ~26h · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

抗抑郁药

氟西汀

Fluoxetine

SSRI

半衰期 2-7天 · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

抗抑郁药

文拉法辛

Venlafaxine

SNRI

半衰期 ~5h · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

抗抑郁药

米氮平

Mirtazapine

NaSSA

半衰期 ~20h · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

抗精神病药

氯丙嗪

Chlorpromazine

典型

半衰期 ~30h · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

抗精神病药

氟哌啶醇

Haloperidol

典型

半衰期 ~21h · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

抗精神病药

奥氮平

Olanzapine

非典型

半衰期 ~33h · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

抗精神病药

利培酮

Risperidone

非典型

半衰期 ~20h · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

抗精神病药

喹硫平

Quetiapine

非典型

半衰期 ~7h · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

文拉法辛

Venlafaxine

抗抑郁药

■ 作用机制

抑制 5-HT 与去甲肾上腺素（NE）再摄取，高剂量兼抑多巴胺再摄取；剂量依赖。

■ 适应症

抑郁症 广泛性焦虑障碍 社交焦虑障碍 惊恐障碍

■ 不良反应

恶心、口干 血压升高（高剂量） 出汗 停用综合征明显 性功能障碍

■ 关键警示

避免与 SSRI/MAOI 联用（5-羟色胺综合征）；停药需逐渐减量。

■ 用法用量

速释 75 – 225 mg/日分次；缓释 75 – 225 mg/日一次。

氟西汀

Fluoxetine

抗抑郁药

■ 作用机制

强效选择性 5-HT 再摄取抑制剂，半衰期长（约 2 – 7 天，活性代谢物更长）。

■ 适应症

抑郁症 强迫症 神经性贪食 双相抑郁（联用心境稳定剂）

■ 不良反应

激越、失眠 食欲下降、体重减轻 性功能障碍 焦虑（初期）

■ 关键警示

与 MAOI 禁忌（需洗脱期）；可能激活（尤其青少年）。

■ 用法用量

起始 20 mg/日，可增至 60 mg/日；因半衰期长，换药间隔较短。

舍曲林

Sertraline

抗抑郁药

■ 作用机制

选择性抑制突触前膜 5-羟色胺（5-HT）再摄取，增强中枢 5-HT 能神经传递。

■ 适应症

抑郁症 强迫症（OCD） 惊恐障碍 创伤后应激障碍（PTSD） 经前烦躁障碍

■ 不良反应

恶心、腹泻等胃肠反应 失眠或嗜睡 性功能障碍 初期激越、焦虑 多汗

■ 关键警示

与 MAOI 合用可致 5-羟色胺综合征（禁忌）；骤停可能出现停药反应；哺乳期慎用。

■ 用法用量

起始 50 mg/日，每周递增 50 mg，最大 200 mg/日；进食不影响吸收。

氟哌啶醇

Haloperidol

抗精神病药

■ 作用机制

高亲和力 D2 受体拮抗，锥体外系风险高，镇静弱于氯丙嗪。

■ 适应症

精神分裂症（阳性症状） 抽动症（Tourette） 急性躁动 / 谵妄 止吐

■ 不良反应

显著 EPS（肌张力障碍、静坐不能） 催乳素升高 QT 延长 镇静较轻

■ 关键警示

EPS 与 NMS 风险；监测 QTc；避免与延长 QT 药物联用。

■ 用法用量

氯丙嗪

Chlorpromazine

抗精神病药

■ 作用机制

典型（第一代）抗精神病药，强效 D2 受体拮抗，兼抗胆碱、抗组胺与 α 受体阻断。

■ 适应症

精神分裂症（阳性症状） 躁狂发作 恶心呕吐 顽固性呃逆 术前镇静

■ 不良反应

锥体外系反应（EPS）显著 镇静 抗胆碱作用（口干、便秘、视物模糊） 体位性低血压 催乳素升高

■ 关键警示

EPS 明显；老年与痴呆患者慎用；注意 QT 延长与恶性综合征（NMS）。

■ 用法用量

米氮平

Mirtazapine

抗抑郁药

■ 作用机制

阻断 α2 自身受体增强 NE/5-HT 释放，并拮抗 5-HT2/5-HT3 与 H1 受体。

■ 适应症

抑郁症（伴失眠、食欲下降） 难治性抑郁增效

■ 不良反应

显著镇静、体重增加 口干 食欲增加 粒细胞减少（罕见）

■ 关键警示

镇静明显，注意跌倒；罕见粒细胞缺乏需监测。

■ 用法用量

15 – 45 mg/日，通常睡前一次；起始 15 mg。

喹硫平

Quetiapine

抗精神病药

■ 作用机制

拮抗 5-HT2A、H1、D2 受体；低剂量以抗组胺 / 镇静为主。

■ 适应症

精神分裂症 双相躁狂与抑郁 难治性失眠（低剂量） 广泛性焦虑（辅助）

■ 不良反应

嗜睡、镇静 体重增加、代谢异常 体位性低血压（起始） 头晕

■ 关键警示

老年人心血管监测；长期白内障风险。

■ 用法用量

利培酮

Risperidone

抗精神病药

■ 作用机制

高亲和力 D2 与 5-HT2A 受体拮抗，锥体外系风险介于典型与非典型之间。

■ 适应症

精神分裂症 双相躁狂 儿童孤独症易激惹 抽动障碍

■ 不良反应

高催乳素血症（溢乳、性功能障碍） 锥体外系反应（剂量相关） 体重增加（轻于奥氮平） 嗜睡

■ 关键警示

监测催乳素与锥体外系；剂量 >6 mg 锥体外系风险升高。

■ 用法用量

奥氮平

Olanzapine

抗精神病药

■ 作用机制

阻断 D2 与 5-HT2A 受体，具多重受体作用（5-HT、D、H1、α1、M1）。

■ 适应症

精神分裂症 双相躁狂 / 混合发作 难治性抑郁增效 化疗相关恶心呕吐

■ 不良反应

显著体重增加、代谢综合征 镇静、嗜睡 血糖、血脂升高 口干、便秘 直立性低血压

■ 关键警示

需监测体重、血糖、血脂；老年痴呆患者慎用（死亡率升高）。

■ 用法用量

抗精神病药

氯氮平

Clozapine

非典型

半衰期 ~12h · 妊娠 B

药枢 · NeuroPharm

抗精神病药

阿立哌唑

Aripiprazole

非典型(部分激动)

半衰期 ~75h · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

心境稳定剂

碳酸锂

Lithium

盐类

半衰期 ~24h · 妊娠 D

药枢 · NeuroPharm

心境稳定剂

丙戊酸钠

Valproate

抗惊厥

半衰期 ~16h · 妊娠 X

药枢 · NeuroPharm

心境稳定剂

卡马西平

Carbamazepine

抗惊厥

半衰期 ~16h · 妊娠 D

药枢 · NeuroPharm

心境稳定剂

拉莫三嗪

Lamotrigine

抗惊厥

半衰期 ~29h · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

抗焦虑药

地西泮

Diazepam

苯二氮草类

半衰期 ~40h · 妊娠 D

药枢 · NeuroPharm

抗焦虑药

阿普唑仑

Alprazolam

苯二氮草类

半衰期 ~12h · 妊娠 D

药枢 · NeuroPharm

兴奋剂

哌甲酯

Methylphenidate

中枢兴奋

半衰期 ~3h · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

碳酸锂

Lithium

心境稳定剂

■ 作用机制

机制未完全阐明；调节第二信使（抑制 GSK-3、肌醇代谢），稳定情绪并降低自杀风险。

■ 适应症

双相障碍躁狂 / 维持期

难治性抑郁增效

降低自杀风险

■ 不良反应

手抖（震颤）

多尿、烦渴（肾性尿崩）

甲状腺功能抑制

体重增加

恶心呕吐（中毒早期）

■ 关键警示

治疗窗窄，须定期监测血锂与肾功能 / 甲状腺；中毒：嗜睡、共济失调、抽搐；脱水、NSAIDs

■ 用法用量

阿立哌唑

Aripiprazole

抗精神病药

■ 作用机制

D2 与 5-HT1A 部分激动剂（常称第三代概念），EPS 与催乳素影响较小。

■ 适应症

精神分裂症

双相躁狂

抑郁症增效

抽动 / 易激惹（儿童）

■ 不良反应

静坐不能、焦虑

轻 EPS

体重增加较轻

失眠

■ 关键警示

静坐不能常见；与强 CYP3A4 诱导剂（如卡马西平）合用药浓度下降。

■ 用法用量

10 – 30 mg/日，每日一次；起始 10 – 15 mg。

氯氮平

Clozapine

抗精神病药

■ 作用机制

多受体作用（D4/5-HT2A 等），对难治性精神分裂症有效，EPS 低。

■ 适应症

难治性精神分裂症

降低精神分裂症自杀风险

■ 不良反应

粒细胞缺乏（须血常规监测）

镇静、流涎

体重增加、代谢异常

心肌炎

癫痫发作

■ 关键警示

粒细胞缺乏（致命）；须注册随访血常规；禁与卡马西平联用。

■ 用法用量

12.5 – 900 mg/日，缓慢滴定；起始 12.5 – 25 mg。

拉莫三嗪

Lamotrigine

心境稳定剂

■ 作用机制

抑制谷氨酸释放，稳定神经元；对双相抑郁与维持期证据较强。

■ 适应症

双相障碍抑郁 / 维持期

癫痫（部分性发作）

■ 不良反应

皮疹（剂量相关，SJS 风险）

头痛

失眠

头晕

■ 关键警示

皮疹可进展为 SJS/TEN；必须缓慢加量；联用卡马西平（诱导）需更快滴定。

■ 用法用量

起始 25 mg/日，极缓慢滴定至 100 – 200 mg/日（与诱导剂/抑制剂联用调整）。

卡马西平

Carbamazepine

心境稳定剂

■ 作用机制

阻断电压门控钠通道，肝酶强诱导剂；用于躁狂与双相维持（尤其混合/快速循环）。

■ 适应症

双相障碍（混合/快速循环）

癫痫

三叉神经痛

■ 不良反应

头晕、复视

粒细胞减少/再生障碍贫血

皮疹（SJS 风险）

肝酶诱导相互作用

■ 关键警示

可显著降低多种药浓度（氯氮平、奥氮平、阿立哌唑等）；SJS 风险；定期血常规。

■ 用法用量

200 – 1200 mg/日分次；缓慢滴定，监测血浓度 4 – 12 mg/L。

丙戊酸钠

Valproate

心境稳定剂

■ 作用机制

增强 GABA 能传递、阻断电压门控钠通道；广义抗惊厥兼心境稳定。

■ 适应症

双相障碍维持期

快速循环型

混合发作

癫痫

偏头痛预防

■ 不良反应

体重增加

脱发

震颤

肝毒性（罕见但严重）

多囊卵巢（女性）

■ 关键警示

育龄女性致畸（神经管缺陷）；肝功能监测；胰腺炎罕见。

■ 用法用量

500 – 2000 mg/日，分次或缓释；监测血浓度 50 – 100 mg/L。

哌甲酯

Methylphenidate

兴奋剂

■ 作用机制

阻断多巴胺与去甲肾上腺素再摄取，增强前额叶 catecholamine 能传导。

■ 适应症

注意缺陷多动障碍（ADHD）

发作性睡病

■ 不良反应

食欲下降、体重减轻

失眠

心率 / 血压升高

腹痛

罕见人格改变

■ 关键警示

监测生长发育与心血管；有滥用潜力（列管）；精神病性症状罕见。

■ 用法用量

儿童 ADHD 起始 5 mg 2 次/日，可增至所需；缓释制剂每日一次。

阿普唑仑

Alprazolam

抗焦虑药

■ 作用机制

中效苯二氮草，强效 GABA 能抑制，抗焦虑与镇静。

■ 适应症

广泛性焦虑障碍

惊恐障碍

■ 不良反应

嗜睡、头晕

依赖与戒断（焦虑反跳）

记忆损害

共济失调

■ 关键警示

戒断可出现癫痫发作（尤其高剂量）；与阿片合用为高危。

■ 用法用量

0.25 – 0.5 mg 2 – 3 次/日，惊恐可至 4 – 6 mg/日；缓慢递减。

地西泮

Diazepam

抗焦虑药

■ 作用机制

增强 GABA_A 受体氯离子内流，抑制中枢兴奋性；长效苯二氮草。

■ 适应症

焦虑障碍

酒精戒断

肌肉痉挛

惊厥（辅助）

术前镇静

■ 不良反应

嗜睡、注意力下降

依赖与耐受

跌倒（老年）

记忆损害

■ 关键警示

依赖性极强，避免长期连续使用；与阿片 / 酒精合用抑制呼吸；老年慎用。

■ 用法用量

抗焦虑 2 – 10 mg 2 – 3 次/日；戒断按方案递减。

抗抑郁药

草酸艾司西酞普兰

Escitalopram

SSRI

半衰期 ~27 – 32h · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

抗抑郁药

阿戈美拉汀

Agomelatine

褪黑素受体激动

半衰期 ~1 – 2h · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

抗抑郁药

伏硫西汀

Vortioxetine

SMS

半衰期 ~66h · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

抗抑郁药

度洛西汀

Duloxetine

SNRI

半衰期 ~12h · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

抗抑郁药

曲唑酮

Trazodone

SARI

半衰期 ~5 – 9h · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

抗精神病药

帕利哌酮

Paliperidone

非典型

半衰期 ~23h · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

抗焦虑药

劳拉西泮

Lorazepam

苯二氮草类

半衰期 ~10 – 20h · 妊娠 D

药枢 · NeuroPharm

抗焦虑药

艾司唑仑

Estazolam

苯二氮草类

半衰期 ~10 – 24h · 妊娠 X

药枢 · NeuroPharm

催眠药

思诺思

Zolpidem

非苯二氮草类(Z)

半衰期 ~2.5h · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

伏硫西汀

Vortioxetine

抗抑郁药

作用机制

抑制 5-HT 再摄取，并调节 5-HT1A/1B/1D/7 与 5-HT3 受体，可能改善认知。

适应症

抑郁症 认知症状（注意力/记忆）伴抑郁

不良反应

恶心 便秘 呕吐 头晕

性功能障碍较轻

关键警示

与 MAOI 禁忌；既往出血史或联用抗凝药注意出血风险。

用法用量

起始 10 mg/日，可 5 – 20 mg/日。

阿戈美拉汀

Agomelatine

抗抑郁药

作用机制

激动 MT1/MT2 褪黑素受体并拮抗 5-HT2C，改善睡眠节律与抑郁。

适应症

抑郁症（伴睡眠节律紊乱） 难治性抑郁

不良反应

头晕、嗜睡 头痛 恶心 转氨酶升高

关键警示

须监测肝功能（ALT/AST），用药前及第 3/6/12/24 周复查；肝损禁用。

用法用量

25 – 50 mg/日，晚间一次。

草酸艾司西酞普兰

Escitalopram

抗抑郁药

作用机制

高选择性 5-HT 再摄取抑制剂（S-对映体），活性强于西酞普兰，对 NE/DA 影响小。

适应症

抑郁症 广泛性焦虑障碍 强迫症

惊恐障碍 社交焦虑障碍

不良反应

恶心、嗜睡 性功能障碍 出汗 失眠

体重轻微变化

关键警示

与 MAOI 禁忌；联用 SSRI 警惕 5-羟色胺综合征；骤停有停药反应。

用法用量

起始 10 mg/日，可增至 20 mg/日；老年 10 mg/日。

帕利哌酮

Paliperidone

抗精神病药

作用机制

利培酮的活性代谢物（9-羟基利培酮），D2/5-HT2A 拮抗，缓释长效。

适应症

精神分裂症 分裂情感障碍

不良反应

锥体外系反应 高催乳素血症 体重增加

嗜睡 静坐不能

关键警示

监测催乳素、锥体外系与代谢；缓释制剂不可掰开或咀嚼。

用法用量

缓释片 3 – 12 mg/日一次（起始 6 mg）；另有每月长效针剂。

曲唑酮

Trazodone

抗抑郁药

作用机制

拮抗 5-HT2A 并抑制 5-HT 再摄取，镇静强、抗焦虑，无明显激活。

适应症

抑郁症（伴失眠） 失眠（低剂量）

焦虑障碍辅助

不良反应

显著镇静 体位性低血压 头晕

阴茎异常勃起（罕见） 口干

关键警示

老年防低血压/跌倒；阴茎异常勃起须急诊处理。

用法用量

抑郁 150 – 400 mg/日分次；失眠 25 – 100 mg 睡前。

度洛西汀

Duloxetine

抗抑郁药

作用机制

抑制 5-HT 与 NE 再摄取，亦用于糖尿病周围神经痛（阻断痛觉传导）。

适应症

抑郁症 广泛性焦虑障碍

糖尿病周围神经痛 纤维肌痛

压力性尿失禁

不良反应

恶心、口干 便秘 出汗 血压升高

嗜睡/失眠 性功能障碍

关键警示

不可与 MAOI 联用；撤药综合征；肝损、闭角青光眼慎用。

用法用量

思诺思

Zolpidem

催眠药

作用机制

选择性结合 GABA_A ω 1 亚基，催眠强、抗焦虑/肌松弱。

适应症

失眠（入睡困难）

不良反应

嗜睡、眩晕 梦游/睡行（罕见）

记忆缺失 次日困倦

关键警示

短期使用；梦游等复杂睡眠行为风险；与酒精/阿片避免合用。

用法用量

成人 5 – 10 mg 睡前（女/老年 5 mg）。

艾司唑仑

Estazolam

抗焦虑药

作用机制

中效苯二氮草，GABA 能抑制，催眠与抗焦虑。

适应症

失眠 焦虑障碍 紧张性头痛辅助

不良反应

嗜睡、头晕 依赖与戒断 记忆损害

共济失调

关键警示

依赖与反跳性失眠；老年防跌倒；与阿片/酒精避免合用。

用法用量

失眠 1 – 2 mg 睡前；焦虑 1 – 2 mg 2 – 3 次/日。

劳拉西泮

Lorazepam

抗焦虑药

作用机制

中效苯二氮草，增强 GABA 能抑制，抗焦虑、镇静、抗惊厥。

适应症

焦虑障碍 失眠（短期） 癫痫持续状态

酒精戒断 术前镇静

不良反应

嗜睡、共济失调 依赖与耐受 记忆损害

跌倒（老年）

关键警示

依赖性较强，避免长期使用；与阿片/酒精合用呼吸抑制高危。

用法用量

抗焦虑 1 – 2 mg 2 – 3 次/日；失眠 2 – 4 mg 睡前；戒断按方案。

催眠药

佐匹克隆

Zopiclone

非苯二氮草类(Z)

半衰期 ~5h · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

催眠药

莱博雷生

Lemborexant

双重食欲素受体拮抗

半衰期 ~17 – 19h · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

相关药物

泰诺

Paracetamol

解热镇痛

半衰期 ~2 – 3h · 妊娠 B

药枢 · NeuroPharm

相关药物

司美格鲁肽

Semaglutide

GLP-1 受体激动

半衰期 ~1 周 · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

相关药物

叶酸

Folic acid

维生素 B9

半衰期 — · 妊娠 A

药枢 · NeuroPharm

相关药物

为力苏

Itopride

胃肠促动力

半衰期 ~6h · 妊娠 B

药枢 · NeuroPharm

抗精神病药

氨磺必利

Amisulpride

非典型(苯甲酰胺)

半衰期 ~12h · 妊娠 C

药枢 · NeuroPharm

泰诺

Paracetamol

相关药物

■ 作用机制
抑制中枢 COX，解热镇痛，外周抗炎弱。

■ 适应症
发热 轻中度疼痛（头痛/牙痛/肌肉痛）

■ 不良反应
恶心 长期或过量肝毒性（严重）
皮疹（罕见）

关键警示
过量致致命肝坏死须及时就医；避免与含对乙酰氨基酚复方药叠加。

■ 用法用量
成人 500 – 1000 mg/次，日≤4000 mg；儿童按体重。

莱博雷生

Lemborexant

催眠药

■ 作用机制
拮抗 OX1R/OX2R 食欲素受体，抑制觉醒、促进入睡与维持睡眠。

■ 适应症
失眠（入睡与维持困难）

■ 不良反应
嗜睡、疲乏 梦境异常 头痛
次日困倦（宿醉感）

关键警示
昂贵；次日宿醉、驾驶注意；与强 CYP3A4 抑制剂/诱导剂避免；重度肝损慎用。

■ 用法用量
5 – 10 mg 睡前，每周≥3 晚规律使用。

佐匹克隆

Zopiclone

催眠药

■ 作用机制
环吡咯酮类，作用于 GABA_A 受体（ ω 1 为主），催眠。

■ 适应症
失眠

■ 不良反应
口苦（金属味） 嗜睡、头晕 次日困倦
记忆损害

关键警示
短期使用；有依赖性；与酒精/中枢抑制药避免合用。

■ 用法用量
3.75 – 7.5 mg 睡前（老年 3.75 mg）。

为力苏

Itopride

相关药物

■ 作用机制
盐酸伊托必利：D2 受体拮抗 + 乙酰胆碱酯酶抑制，促进胃肠蠕动。

■ 适应症
功能性消化不良 胃轻瘫
餐后饱胀、恶心

■ 不良反应
腹痛、腹泻 口干 头痛
罕见心律失常

关键警示
胃肠道出血/梗阻/穿孔禁忌；心律失常者慎用。

■ 用法用量
50 mg 3 次/日饭前。

叶酸

Folic acid

相关药物

■ 作用机制
参与一碳代谢与核酸合成，缺乏与抑郁、高同型半胱氨酸相关。

■ 适应症
叶酸缺乏 妊娠预防神经管缺陷
抑郁辅助（联合治疗）

■ 不良反应
少见 大剂量掩盖维生素 B12 缺乏

关键警示
大剂量可掩盖维生素 B12 缺乏致神经损害；常作为抑郁增效辅助。

■ 用法用量
0.4 – 5 mg/日（补充/治疗剂量不同）。

司美格鲁肽

Semaglutide

相关药物

■ 作用机制
GLP-1 受体激动剂，延缓胃排空、抑制食欲，降糖并减重。

■ 适应症
2 型糖尿病 肥胖/超重（减重适应症）

■ 不良反应
恶心、呕吐 腹泻/便秘 食欲下降
胰腺炎风险（罕见）
甲状腺 C 细胞肿瘤警示

关键警示
甲状腺髓样癌个人/家族史禁忌；胰腺炎史慎用；减重需配合生活方式。

■ 用法用量
皮下注射 0.25 – 2.4 mg/周（减重），逐步递增。

氨磺必利

Amisulpride

抗精神病药

■ 作用机制
苯甲酰胺类非典型抗精神病药。低剂量选择性拮抗突触前 D2/D3 自身受体，促进多巴胺释放，改...

■ 适应症
精神分裂症（阳性与阴性症状）
慢性低动力/阴性症状突出者
低落性心境障碍（低剂量，部分国家适应症）

■ 不良反应
高催乳素血症（溢乳、性功能障碍、闭经、骨密度
体重增加（较其他非典型轻）
锥体外系反应（高剂量） 失眠、激越
QT 间期延长（罕见）

■ 用法用量